

Indicaciones, contraindicaciones y elección del método anticonceptivo según paciente

1. Introducción y relevancia clínica

La **anticoncepción personalizada** es un pilar de la salud sexual y reproductiva.

No todos los métodos son adecuados para todas las mujeres: su elección depende de **edad, comorbilidades, hábitos, estado fisiológico (lactancia, puerperio) y preferencias personales**.

El uso inadecuado de anticonceptivos puede asociarse a **fallas, complicaciones trombóticas, efectos metabólicos o interacciones farmacológicas**, por lo que el médico debe conocer las **indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas**.

En Chile, el **MINSAL** (Norma Técnica 2023) y la **OMS (Criterios Médicos de Elegibilidad, 2015, actualizados 2023)** establecen guías para prescribir de forma **segura, informada y basada en evidencia**.

□ En EUNACOM, se suele preguntar:

- “¿Qué método puede usar una mujer lactante de 3 meses?”
 - “¿Qué anticonceptivo está contraindicado en una fumadora de 38 años?”
 - “¿Qué criterio OMS corresponde a una hipertensa controlada?”
-

2. Clasificación OMS de elegibilidad médica

La OMS agrupa cada condición médica en **4 categorías** según el riesgo/beneficio del uso de anticonceptivos:

Categoría	Significado	Conducta
1	Sin restricción	Se puede usar libremente

2	Ventajas superan riesgos	Se puede usar con control
3	Riesgos superan ventajas	Evitar, salvo que no haya alternativa
4	Riesgo inaceptable	Contraindicado

Ejemplo clásico:

- Fumadora <35 años → categoría 2 para AOC (uso posible).
- Fumadora ≥35 años → categoría 4 (contraindicado).

3. Tipos de métodos anticonceptivos (resumen)

Grupo	Ejemplo	Eficacia (uso típico)
Combinados (estrógeno + progestina)	Píldoras, parche, anillo	91%
Solo progestina	Minipíldora, inyectable, implante, DIU-LNG	94–99%
Dispositivo intrauterino (no hormonal)	DIU CuT-380A	>99%
Métodos de barrera	Preservativo masculino/femenino, diafragma	80–90%
Métodos definitivos	Ligadura tubaria, vasectomía	>99%

4. Indicaciones generales por edad y etapa vital

Etapa	Método(s) preferido(s)	Comentario
Adolescente	AOC, implante, DIU-LNG, preservativo	Promover doble protección (ITS + anticoncepción)
Mujer adulta sana (<35 años)	Cualquier método	Según preferencia
Fumadora >35 años	Métodos sin estrógeno: progestina o DIU	Evitar combinados
Lactancia (<6 meses)	Progestina sola, DIU Cu/LNG	Estrógeno disminuye producción láctea
Posparto >6 semanas (no lactancia)	AOC, parche, anillo	Tras descartar trombosis
Perimenopausia	DIU-LNG, progestina o ligadura	Evaluar riesgo trombótico
Postmenopausia precoz (terapia hormonal)	THR no es anticonceptivo	Añadir método adicional si riesgo de embarazo aún existe

5. Indicaciones y contraindicaciones específicas

a.

Métodos combinados (estrógeno + progestina)

Indicaciones:

- Mujeres sanas, menores de 35 años.
- Regulación menstrual, dismenorrea, síndrome premenstrual.
- Endometriosis leve, acné.

Contraindicaciones**absolutas (categoría 4 OMS):**

- Trombosis venosa profunda o embolia pulmonar actual o previa.
- Cáncer de mama actual.
- Enfermedad hepática activa o tumores hepáticos.
- Migraña con aura.
- Hipertensión no controlada (>160/100 mmHg).
- Fumadora ≥35 años (>15 cig/día).
- Lactancia <6 semanas postparto.

Contraindicaciones**relativas (categoría 3 OMS):**

- Fumadora <35 años.
- Hipertensión leve controlada.
- Diabetes sin complicaciones.
- IMC >35.

b.

Métodos solo progestínicos

Incluyen minipíldora, inyectables, implante y DIU-LNG.

Indicaciones:

- Lactancia.
- Contraindicación a estrógenos.
- Trombofilia o antecedente de trombosis.
- Migraña con aura.
- Mujeres mayores de 35 años fumadoras.
- Dismenorrea, SUA funcional.

Contraindicaciones:

- Cáncer de mama actual.
- Sangrado genital no aclarado.
- Hepatopatía severa activa.

☐ En EUNACOM: "Mujer de 38 años fumadora → usar progestina sola o DIU-LNG."

C.**Dispositivo intrauterino (DIU)****Indicaciones:**

- Deseo de anticoncepción prolongada y reversible.
- Paridad completada o lactancia.
- Uso terapéutico: SUA, dismenorrea, endometriosis (DIU-LNG).

Contraindicaciones absolutas:

- Embarazo actual o sospecha.
- Infección pélvica activa.
- Malformaciones uterinas severas.

- Cáncer cervical o endometrial.

Contraindicaciones relativas:

- Anemia grave (para DIU de cobre).
- Cuello estenosado o manipulación cervical dificultosa.
- Historia de EPI recurrente.

d.

Anticonceptivos inyectables (acetato de medroxiprogesterona)

- Indicados en lactancia y mujeres con baja adherencia a píldoras.
 - Contraindicados en cáncer de mama actual o sangrado inexplicado.
 - Pueden producir amenorrea o aumento de peso.
 - **Uso prolongado (>2 años)** puede disminuir densidad ósea → precaución en adolescentes.
-

6. Elección del método según condición clínica

Condición	Método recomendado	Evitar
Fumadora <35 años	Cualquiera	—
Fumadora ≥35 años	Progestina sola, DIU	Combinados
HTA controlada	DIU o progestina	Combinados

HTA no controlada	DIU	Todos los hormonales
DM sin complicaciones	AOC o progestina	—
DM con nefropatía, retinopatía	Progestina o DIU	Combinados
Trombosis venosa previa	DIU o progestina	Combinados
Migraña sin aura	Combinados con precaución	—
Migraña con aura	Progestina o DIU	Combinados
Lactancia <6 semanas	Progestina o DIU	Combinados
Obesidad (IMC>30)	DIU, implante	AOC (menor eficacia)
Anemia ferropénica	DIU-LNG	DIU cobre
Endometriosis / dismenorrea severa	DIU-LNG o AOC continuos	DIU cobre
Antecedente de cáncer de mama	DIU cobre	Hormonales

7. Consideraciones especiales

a.

Anticoncepción postparto

- <6 semanas: progestina sola o DIU.
- 6 semanas: cualquier método si no hay trombosis.
- AOC no deben iniciarse antes de 6 semanas por riesgo trombótico y supresión láctea.

b.

Anticoncepción en adolescentes

- Promover **métodos de larga duración (LARC)**: implante subdérmico o DIU-LNG.
- Acompañar siempre de **educación y consejería en ITS**.

c.

Pacientes VIH positivas

- Pueden usar cualquier método hormonal si están clínicamente estables.
- Evitar interacciones farmacológicas con algunos antirretrovirales (efavirenz disminuye eficacia del implante).

d.

Pacientes con discapacidad o patologías psiquiátricas

- Privilegiar métodos de **larga duración** y bajo mantenimiento (implante o DIU-LNG).

8. Factores de adherencia y elección informada

La elección no debe basarse solo en factores médicos, sino también en:

- **Preferencias personales.**
- **Accesibilidad y cobertura (MINSAL).**

- **Facilidad de uso y adherencia.**
- **Efectos secundarios aceptables.**
- **Protección contra ITS (preservativos siempre recomendados).**

El principio clave es la **libertad reproductiva informada**: el rol del médico es orientar, no imponer.

9. Evaluación previa y seguimiento

a. Evaluación inicial

- Anamnesis completa (antecedentes trombóticos, cáncer, migrañas, tabaquismo).
- Presión arterial y peso.
- Examen ginecológico y prueba de embarazo si corresponde.

b. Seguimiento

- Control a los 3 meses del inicio, luego anual.
 - Evaluar efectos adversos, adherencia, tensión arterial y peso.
 - Reforzar educación sobre ITS y uso dual con preservativo.
-

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Criterios OMS 1–4** guían la elección del método según riesgo/beneficio.
2. **Estrógenos** están contraindicados en fumadoras ≥ 35 años, trombosis, migraña con aura y HTA no controlada.

3. **Progestina sola o DIU** son opciones seguras en lactancia y riesgo cardiovascular.
4. **DIU-LNG** es ideal en SUA o dismenorrea.
5. **AOC combinados** mejoran acné, regulan ciclo y reducen riesgo de cáncer de ovario.
6. En **menores de 6 semanas postparto**, evitar estrógenos.
7. En **obesidad o adherencia deficiente**, preferir **métodos LARC (implante o DIU)**.



Errores comunes

- Prescribir AOC en fumadoras mayores de 35 años.
- Usar combinados durante lactancia precoz.
- No ofrecer DIU o implante por mitos o prejuicios.
- No evaluar presión arterial antes de indicar AOC.
- Omitir consejería sobre ITS en adolescentes.

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La elección anticonceptiva debe ser **individualizada según edad, lactancia, comorbilidades y preferencia**.
2. Los **criterios OMS 1–4** orientan la seguridad de cada método.
3. **Estrógeno combinado** contraindicado en fumadoras ≥ 35 años, HTA no controlada, trombosis, migraña con aura.
4. **Progestina sola y DIU** son seguros en lactancia y riesgo vascular.
5. **LARC (implante y DIU)** tienen la mayor eficacia y adherencia.
6. **Evaluar y controlar presión arterial y antecedentes trombóticos** antes de prescribir.

7. Toda consejería anticonceptiva debe incluir **educación en ITS y derechos reproductivos**.